MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE COSTA RICA

Boletín Epidemiológico N° 40 de 2026

Dirección de Vigilancia de la Salud

Ministerio de Salud

30 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Arbovirosis 3

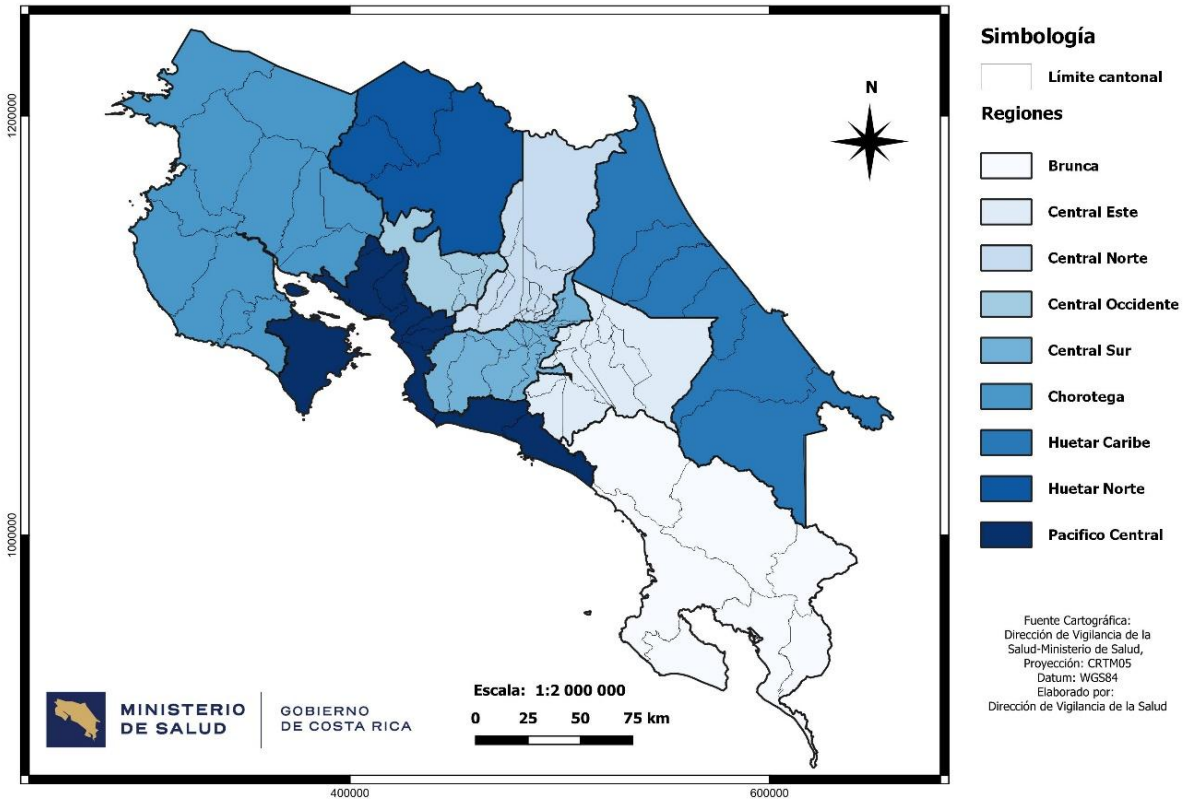
Situación de la malaria en Costa Rica 7

Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 40 17

Miasis por gusano barrenador en humanos 18

Comportamiento de trastornos mentales notificados en personas adultas mayores. 23

Costa Rica. Regionalización Ministerio de Salud, 2024



Arbovirosis

Dengue

A la semana epidemiológica 41 del año 2026 se notifican **6285 casos acumulados** de dengue de estos, **98 casos** como dengue con signos de alarma.
La Gerencia Médica de la CCSS a través del Área de Estadística en Salud según los datos recopilados mediante EDUS informa que al 26 de octubre se reportan 4 personas hospitalizadas con diagnóstico de dengue: 2 en el Hospital Enrique Baltodano y 2 en el Hospital San Francisco de Asís.
La región Central Norte presenta el mayor número de casos notificados 1861 y la tasa más alta la presenta la región Pacífico Central con 420,7/100.000 habitantes.

Tabla 1.
Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región a la semana epidemiológica 41 2026 (Tasa por 100.000 hab.)

Región	Casos	Tasa
Central Norte	1861	177,7
Pacifico Central	1354	420,7
Chorotega	839	176,8
Central Sur	796	52,6
Huetar Caribe	513	112,0
Central Occidente	324	144,3
Huetar Norte	285	105,0
Brunca	239	67,7
Central Este	74	13,4
Total	6285	120,5

Fuente: Base VE01, Dirección de Vigilancia de la Salud.

Tabla 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia y sexo, 2026

Provincia	Total casos	Tasa	Femenino	Tasa	Masculino	Tasa
Alajuela	2724	251,6	1438	266,1	1286	237,1
Puntarenas	940	184,7	436	173,2	504	196,0
San José	815	48,9	403	47,7	412	50,2
Guanacaste	795	190,6	411	198,7	384	182,7
Limón	513	112,0	231	103,2	282	120,5
Heredia	424	77,0	226	81,7	198	72,3
Cartago	74	13,9	37	13,8	37	14,0
Total	**6285**	**120,5**	**3182**	**121,8**	**3103**	**119,2**

Fuente: Base VE 01, Dirección de Vigilancia de la Salud.

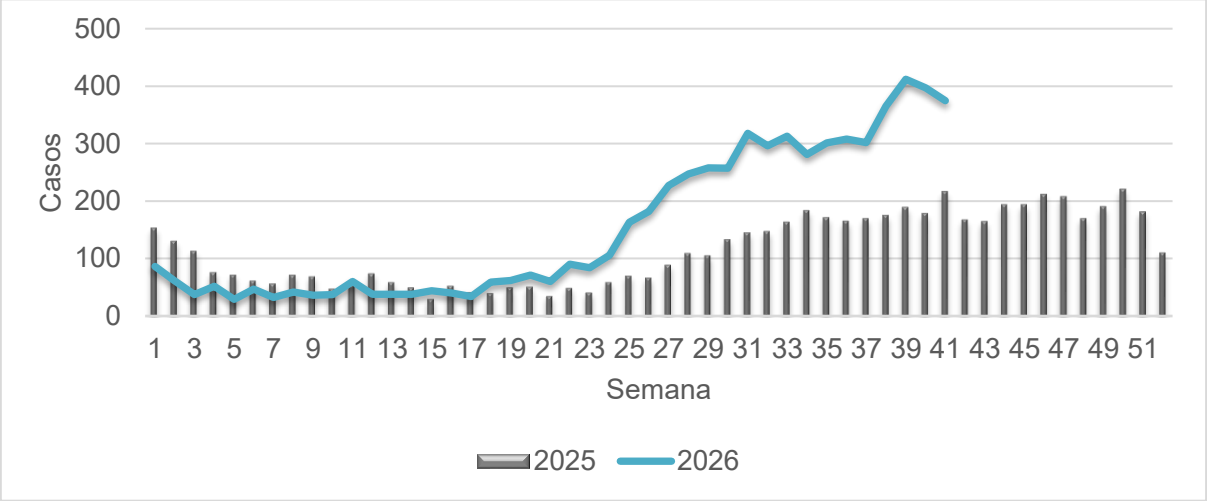
Los cantones con mayor número de casos acumulados a la semana epidemiológica 41 son: Grecia 704 casos, Alajuela 627 casos, Orotina 572 casos, Puntarenas 387 casos y San José 376 casos.

Tabla 3.
Costa Rica: cantones prioritarios de dengue por casos notificados a la semana epidemiológica 41, 2026.

Cantón	Casos	Tasa
203: Grecia	704	865,0
201: Alajuela	627	189,9
209: Orotina	572	2249,1
601: Puntarenas	387	265,8
101: San José	376	106,2
510: La Cruz	233	821,6
401: Heredia	211	143,2
702: Pococí	176	111,9
210: San Carlos	169	79,2
501: Liberia	153	185,3

Fuente: Base VE01, Dirección de Vigilancia de la Salud

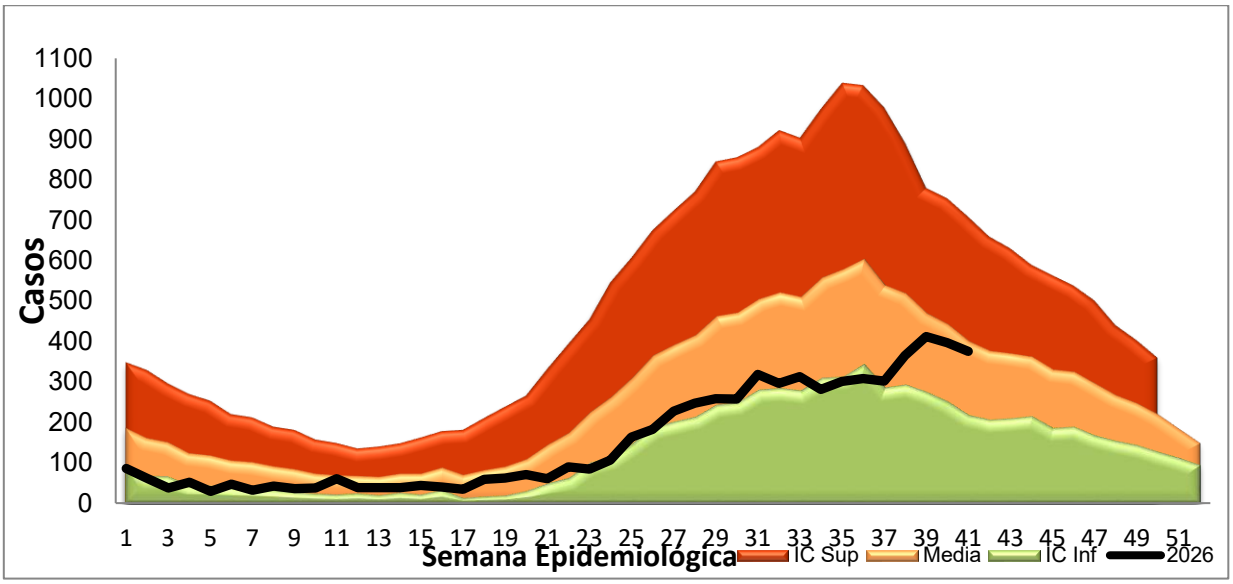
Gráfico 1.
Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 41, 2025-2026.



Fuente: Base VE01, Dirección de Vigilancia de la Salud

Para la semana epidemiológica 41 del año 2025 se reportaron 4014 casos. En comparación con ese período, para el año 2026 se observa un incremento del 36% en el número de casos notificados.

Gráfico 2.
Costa Rica: canal endémico de dengue a la semana epidemiológica 41, 2026.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Chikungunya

A la semana epidemiológica 41 se notifica un total de **974 casos** de chikungunya, **847 casos confirmados** por prueba de PCR y **127 casos probables** en estudio.

Tabla 4.
Costa Rica: Casos de chikungunya por región notificados y confirmados a la semana epidemiológica 41, 2026

Región	Total	Confirmados	Probables
Chorotega	576	510	66
Central Norte	157	146	11
Central Sur	116	92	24
Pacifico Central	42	37	5
Huetar Norte	42	38	4
Central Occidente	21	14	7
Central Este	11	7	4
Huetar Caribe	6	2	4
Brunca	3	1	2
Total	**974**	**847**	**127**

Fuente: Base VE01, Dirección de Vigilancia de la Salud

Los cantones con mayor reporte de casos son:

- La Cruz 390 casos
- Alajuela 114 casos
- Carrillo 83 casos
- San José 65 casos
- Santa Cruz 59 casos
- Los Chiles 24 casos

Situación de la malaria en Costa Rica

Actualización a la semana epidemiológica 41 del 2026

En 2026 se registran 37 casos de malaria por transmisión local

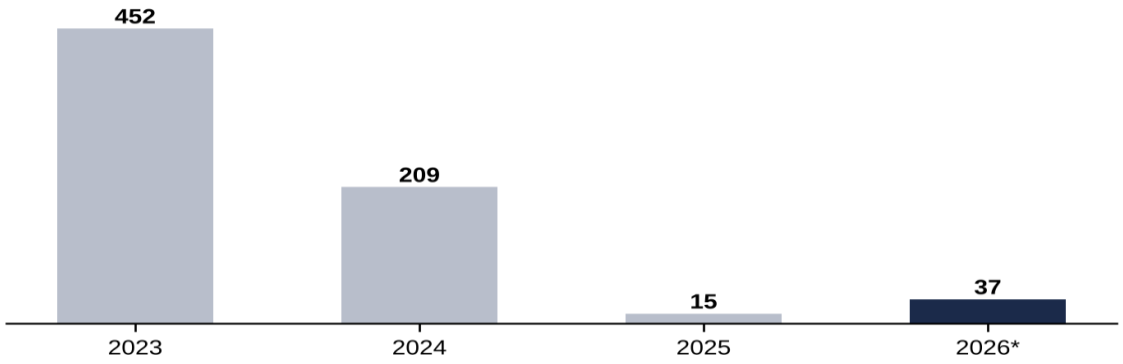
Los casos de transmisión local son los que se adquirieron dentro del país: 19 autóctonos y 18 introducidos. El 81 % corresponde al **foco Crucitas** (distrito de Cutris, cantón de San Carlos, Región Huetar Norte), una zona de minería artesanal en la frontera con Nicaragua. **En la SE 37 se confirmaron 3 casos introducidos en la Región Chorotega** (Nicoya y Hojancha), en trabajadores vinculados a un mismo lugar de trabajo en Sámara; es el último registro de transmisión local (diagnóstico del 22 de setiembre). Otros 8 casos confirmados permanecen en estudio, pendientes de clasificación epidemiológica.

37	19	18	50	0
TRANSMISIÓN LOCAL	AUTÓCTONOS	INTRODUCIDOS	IMPORTADOS	DEFUNCIONES

Comparación histórica de la transmisión local

Los casos de transmisión local acumulados a la SE 41 se redujeron de **452 en 2023 a 37 en 2026** (−91,8 %) y de 209 en 2024 (−82,3 %). Respecto a 2025 (15 casos) hay un aumento de 146,7 %, atribuible principalmente al brote del foco Crucitas.

Gráfico 1.
Casos de malaria por transmisión local acumulados a la SE 41, Costa Rica, 2023–2026

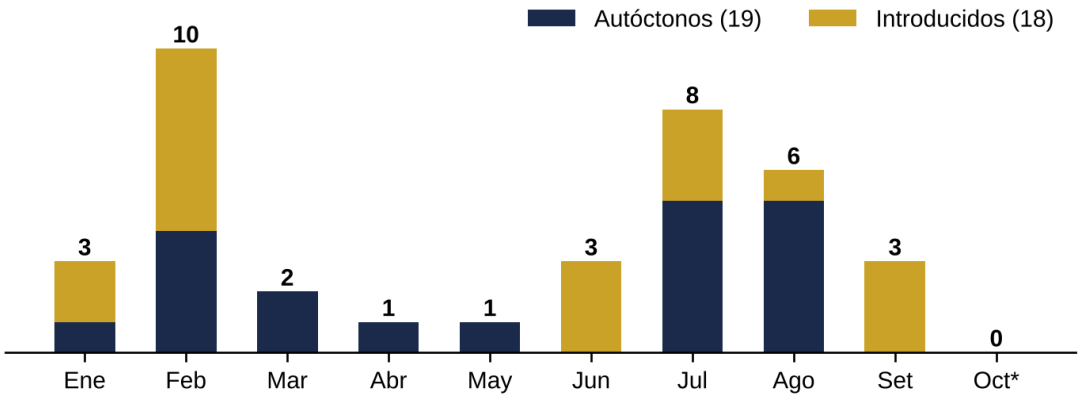


*2026: datos a la SE 41.
Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Distribución temporal

La transmisión local se concentró en dos periodos: **febrero** (10 casos, 6 introducidos) y **julio–agosto** (14 casos, 10 autóctonos). En **setiembre** se registraron 3 casos introducidos en Guanacaste. En octubre no se registran casos de transmisión local confirmados.

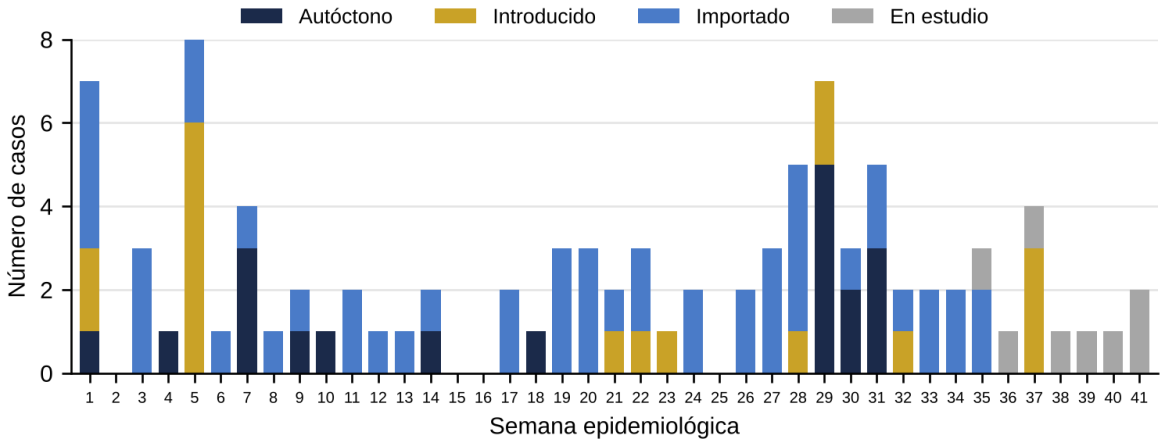
Gráfico 2.
Casos de malaria por transmisión local según mes de diagnóstico y clasificación epidemiológica, Costa Rica, enero–octubre 2026



*Octubre: datos a la SE 41.
Las cifras recientes pueden variar al cerrarse las investigaciones en curso.

Al incluir todos los casos confirmados, los casos importados se presentan de forma continua durante el año, mientras que la transmisión local se agrupa en las semanas 1–7, 28–32 y 37. Los 8 casos de las SE 35 a 41 aún sin clasificación permanecen en estudio.

Gráfico 3.
Casos confirmados de malaria según semana epidemiológica y clasificación epidemiológica, Costa Rica, 2026 (corte SE 41)

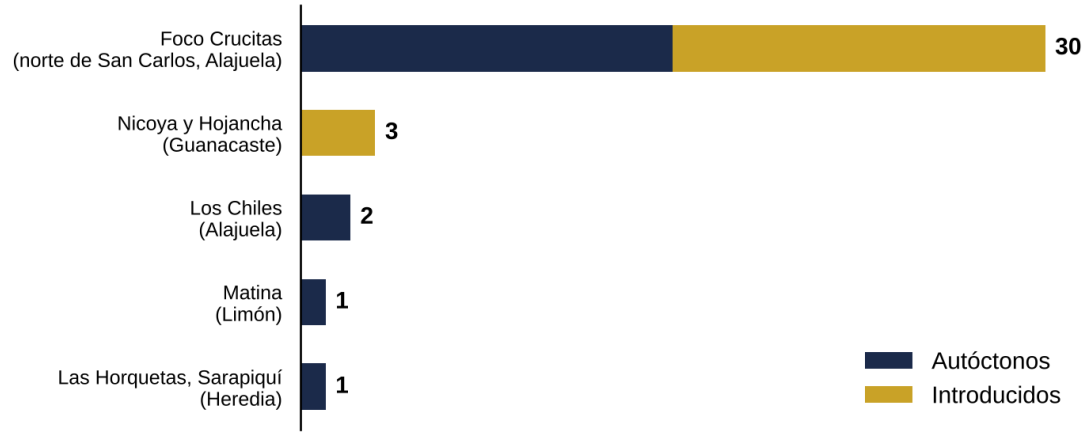


Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Distribución geográfica por foco

El foco Crucitas concentra 30 de los 37 casos de transmisión local (81 %): 15 autóctonos y 15 introducidos. La mayoría reside en el distrito de Cutris, y la localidad de El Roble aporta 15 casos. Es una zona de minería artesanal de oro con alta movilidad poblacional transfronteriza. Fuera de Crucitas se registran 3 casos introducidos en Nicoya y Hojancha (Guanacaste), sin foco asignado, y casos autóctonos aislados en Los Chiles (2), Matina (1, por *P. falciparum*) y Las Horquetas de Sarapiquí (1, sin foco asignado y con origen de infección no determinado).

Gráfico 4.
Casos de malaria por transmisión local según foco o área y clasificación epidemiológica, Costa Rica, 2026



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

La Región Huetar Norte concentra 75 de los 95 casos confirmados del año, incluidos 15 de los 18 introducidos y 17 de los 19 autóctonos. La Región Chorotega registra 3 casos introducidos. En las demás regiones predominan los casos importados.

Tabla 1.
Casos confirmados de malaria por región de salud y clasificación epidemiológica, Costa Rica, 2026 (corte SE 41)

Región	Autóctono	Introducido	Importado	En estudio	Total
Huetar Norte	17	15	35	8	75
Central Sur	0	0	5	0	5
Huetar Caribe	1	0	4	0	5
Chorotega	0	3	1	0	4
Pacífico Central	0	0	2	0	2
Central Norte	1	0	1	0	2
Brunca	0	0	1	0	1
Central Occidente	0	0	1	0	1
Total	**19**	**18**	**50**	**8**	**95**

Fuente: Coordinación de Malaria, DVS, Ministerio de Salud

Tabla 2.
Casos confirmados de malaria según foco y clasificación epidemiológica, Costa Rica, 2026 (corte SE 41)

Foco	Autóctono	Introducido	Importado	En estudio	Total
Crucitas	15	15	31	7	68
Los Chiles	2	0	1	1	4
Pital	0	0	2	0	2
Matina	1	0	0	0	1
Sin foco asignado	1*	3†	16	0	20
Total	**19**	**18**	**50**	**8**	**95**

Foco según registro de la investigación de caso. Transmisión local por especie: Crucitas 15 autóctonos *P. vivax*, 14 introducidos *P. vivax* y 1 introducido *P. falciparum*; Nicoya y Hojancha 3 introducidos *P. vivax*; Los Chiles 2 autóctonos *P. vivax*; Matina 1 autóctono *P. falciparum*; Las Horquetas 1 autóctono *P. vivax*. * Caso autóctono sin foco asignado, con origen de infección no determinado. † Casos introducidos de Nicoya y Hojancha (Región Chorotega).
Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Características de los casos de transmisión local

- **Sexo:** 28 hombres (76 %) y 9 mujeres (24 %).
- **Edad:** mediana de 33 años (rango 1–55); predominan los adultos jóvenes en edad productiva.
- **Ocupación:** 18 casos (49 %) se dedican a la minería artesanal (coligalleros y mineros).
- **Nacionalidad:** 25 nicaragüenses (68 %) y 12 costarricenses (32 %).
- **Gravedad:** 7 casos hospitalizados (19 %). Sin defunciones.
- **Especie parasitaria:** *P. vivax* en 35 casos (95 %) y *P. falciparum* en 2 (1 introducido en Crucitas y 1 autóctono en Matina).

Acciones de vigilancia y control

- **Búsqueda reactiva:** alrededor de los 37 casos de transmisión local se tomaron muestras a **1 384 personas** para detectar a tiempo otras infecciones; 6 resultaron positivas.
- **Búsqueda activa:** 22 de los 37 casos (59 %) se detectaron porque los equipos de salud salieron a buscarlos en la comunidad (búsqueda reactiva o proactiva), antes de que la persona consultara.
- **Investigación de cada caso** para identificar el lugar probable de infección y orientar las acciones de control en el foco.
- **Coordinación interinstitucional** entre el Ministerio de Salud, la CCSS y los colaboradores voluntarios (ColVol) de las comunidades.

Vigilancia diagnóstica

En 2026 se han realizado **165 536 pruebas diagnósticas de malaria**. La prueba de diagnóstico rápido (PDR) representa el 96 % (158 151), seguida de la gota gruesa (7 207) y la PCR (178). El Ministerio de Salud aplicó 81 228 PDR, los colaboradores voluntarios (ColVol) 1 457 y la CCSS realizó 82 851 pruebas en sus establecimientos. Con 95 casos confirmados, se detecta aproximadamente 1 caso por cada 1 740 pruebas realizadas.

Tabla 3.
Pruebas diagnósticas de malaria realizadas según institución y tipo de prueba, Costa Rica, 2026

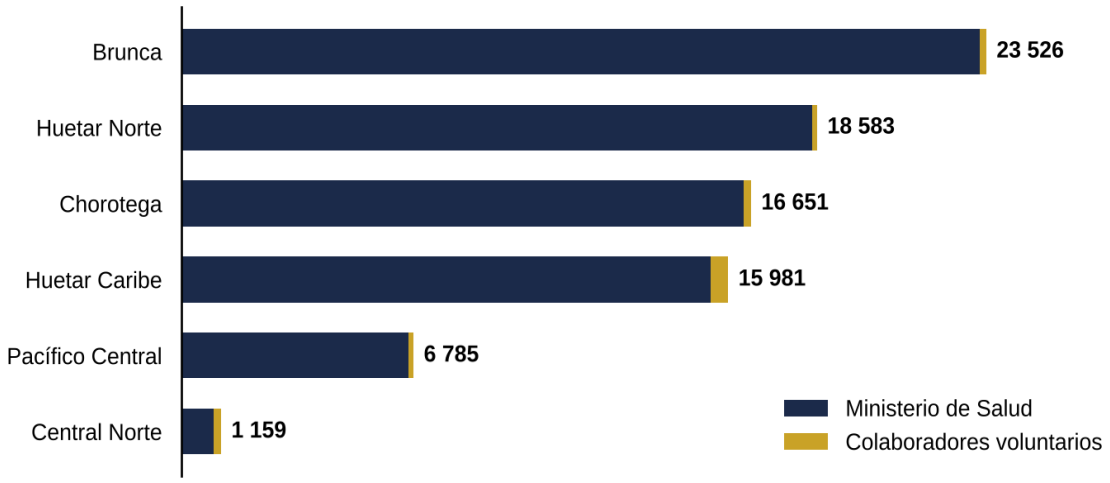
Institución	PDR	Gota gruesa	PCR	Total
Ministerio de Salud	81 228	—	—	81 228
Colaboradores voluntarios (ColVol)	1 457	—	—	1 457
CCSS	75 466	7 207	178	82 851
Total	**158 151**	**7 207**	**178**	**165 536**

No incluye pruebas de G6PD.

Fuente: Coordinación de Malaria, Ministerio de Salud; Caja Costarricense de Seguro Social.

En la CCSS, la mayor parte de las pruebas se procesa en laboratorio (43 349) y en los EBAIS (28 669). En la búsqueda comunitaria del Ministerio de Salud y ColVol (82 685 PDR), las regiones Brunca, Huetar Norte, Chorotega y Huetar Caribe concentran el 90 % de las PDR aplicadas.

Gráfico 5.
Pruebas de diagnóstico rápido (PDR) aplicadas por el Ministerio de Salud y colaboradores voluntarios según región de salud, Costa Rica, 2026



Fuente: Registro de pruebas diagnósticas, Ministerio de Salud.

Casos importados y en estudio

Se registran **50 casos importados**; en 46 el lugar probable de infección es Nicaragua y 10 corresponden a recaídas por *P. vivax*. **8 casos permanecen en estudio**, todos en la Región Huetar Norte (7 en el foco Crucitas y 1 en Los Chiles). La investigación de estos casos determinará dónde ocurrió la infección. En total se han confirmado 95 casos de malaria en 2026.

Tabla 4.
Casos importados según país probable de infección y especie, Costa Rica, 2026 (corte SE 41)

País probable de infección	Especie	Casos
Brasil	*P. vivax*	1
Etiopía	*P. vivax*	1
Nicaragua	Mixta (*P. falciparum* / *P. vivax*)	1
Nicaragua	*P. falciparum*	5
Nicaragua	*P. vivax*	40
No especificado†	*P. vivax*	1
Venezuela (recaída)*	*P. vivax*	1
Total		**50**

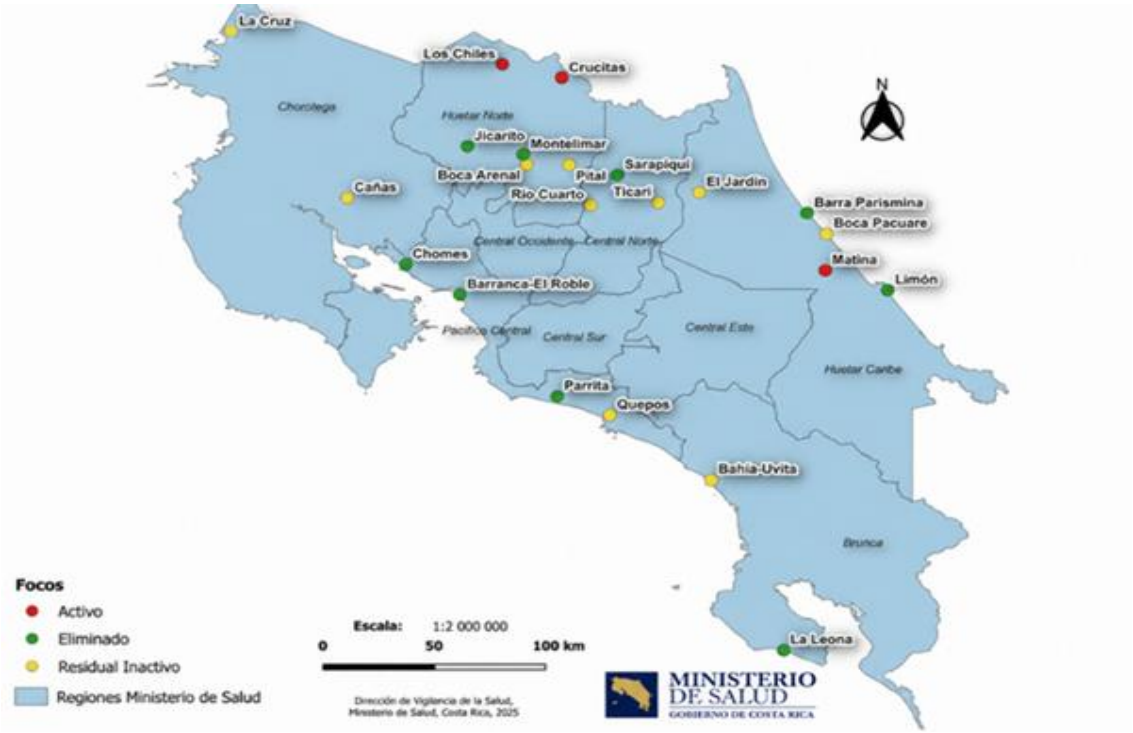
10 casos importados corresponden a recaídas por *P. vivax*. * Recaída en persona venezolana con antecedente de tránsito por el Darién. † Lugar probable de infección sin país especificado.
Fuente: Registro de pruebas diagnósticas, Ministerio de Salud.

Inventario de focos

El país mantiene un inventario de focos en actualización constante. Actualmente hay **3 focos activos** (Crucitas–Llano Verde, Los Chiles y Matina), **10 focos residuales inactivos** y **9 focos eliminados**.

Figura 1.

Distribución geográfica de focos de malaria según estado epidemiológico, Costa Rica, agosto 2026



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Para que un foco se declare residual inactivo debe pasar 1 año sin casos autóctonos; para declararlo eliminado deben pasar 3 años sin transmisión autóctona del parásito.

Tabla 5.
Focos de malaria según estado epidemiológico, provincia y cantón, Costa Rica, 2026

Estado del foco	Provincia	Cantón	Foco
Activo	Alajuela	San Carlos	Crucitas–Llano Verde
Activo	Alajuela	Los Chiles	Los Chiles
Activo	Limón	Matina	Matina
Residual inactivo	Alajuela	San Carlos	Boca Arenal
Residual inactivo	Alajuela	Río Cuarto	Río Cuarto
Residual inactivo	Guanacaste	La Cruz	La Cruz
Residual inactivo	Guanacaste	Cañas	Cañas
Residual inactivo	Heredia	Sarapiquí	Ticarí
Residual inactivo	Limón	Limón	Limón
Residual inactivo	Limón	Pococí	El Jardín
Residual inactivo	Limón	Siquirres	Barra Pacuare
Residual inactivo	Puntarenas	Quepos	Quepos
Residual inactivo	Puntarenas	Osa	Bahía Uvita
Eliminado	Alajuela	San Carlos	Pital
Eliminado	Alajuela	San Carlos	Montelimar
Eliminado	Alajuela	San Carlos	Jicarito
Eliminado	Heredia	Sarapiquí	Sarapiquí
Eliminado	Limón	Siquirres	Barra de Parismina
Eliminado	Puntarenas	Puntarenas	Barranca–El Roble
Eliminado	Puntarenas	Puntarenas	Chomes
Eliminado	Puntarenas	Parrita	Parrita
Eliminado	Puntarenas	Golfito	La Leona

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Recomendaciones a la población

- Si presenta **fiebre, escalofríos, sudoración o dolor de cabeza** y vive, trabaja o viajó a la zona norte del país o a un país con malaria, **acuda de inmediato al EBAIS o centro de salud** más cercano e indique dónde estuvo.
- La malaria **tiene cura**. Complete el tratamiento indicado, aunque se sienta mejor, y asista a los controles de gota gruesa.
- Protéjase de la picadura del mosquito *Anopheles*, sobre todo al atardecer y en la noche: use mosquitero, repelente y ropa de manga larga.
- Permita la visita de los equipos de salud y la toma de muestras en su comunidad; así se detectan los casos a tiempo.

Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 40

En la siguiente tabla se desglosan las acciones de control vectorial que se han realizado en la semana epidemiológica 40 del 2026, por el personal de Control de Vectores del país.

Tabla 1.
Costa Rica: Acciones de control vectorial en la semana epidemiológica 40.

Acciones realizadas	Total
Viviendas visitadas	**14 621**
Viviendas positivas	**826**
Depósitos tratados	**43 784**
Depósitos eliminados	**17 669**
Criaderos	**61 453**
Depósitos positivos	**1 418**
Viviendas fumigadas	**31 210**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Tabla 2
Costa Rica: Acciones acumuladas de control vectorial de la semana epidemiológica 1 a la 40.

Acciones realizadas	Total
Viviendas visitadas	**501 113**
Viviendas positivas	**24 075**
Depósitos tratados	**1 768 997**
Depósitos eliminados	**1 371 117**
Criaderos	**3 140 114**
Depósitos positivos	**55 942**
Viviendas fumigadas	**783 751**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

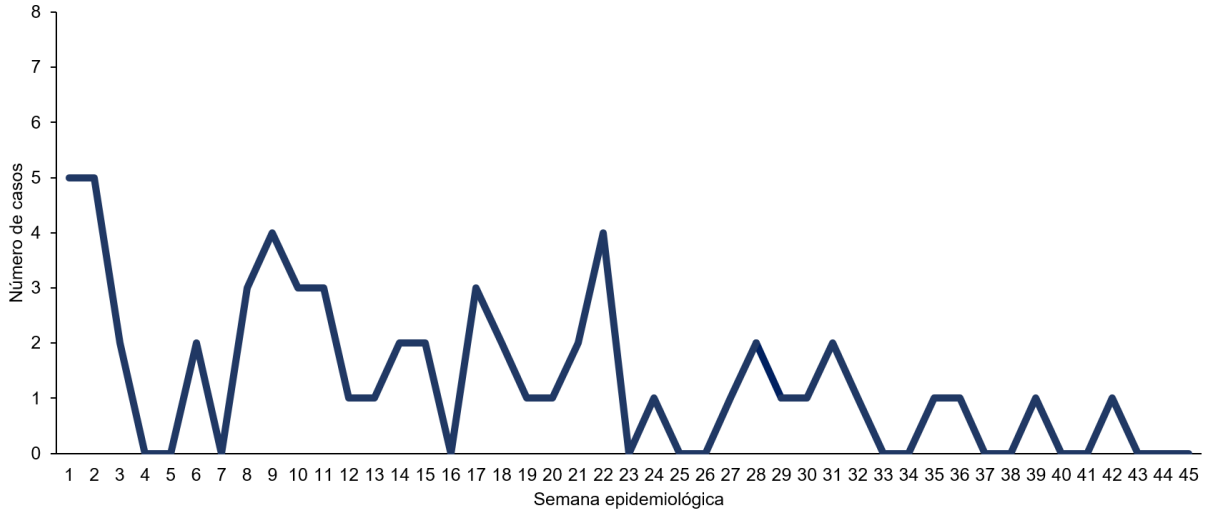
Miasis por gusano barrenador en humanos

A continuación, se presentan los datos preliminares de miasis por gusano barrenador en humanos correspondientes a la semana epidemiológica (SE) 42 del año 2026. De conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 40556-S Reglamento de Vigilancia de la Salud y el Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos, este evento es de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

Con respecto a la notificación de casos mediante la boleta VE-01, para el período comprendido entre la SE 1 a la SE 42 del año 2026, se dispone de la siguiente información:

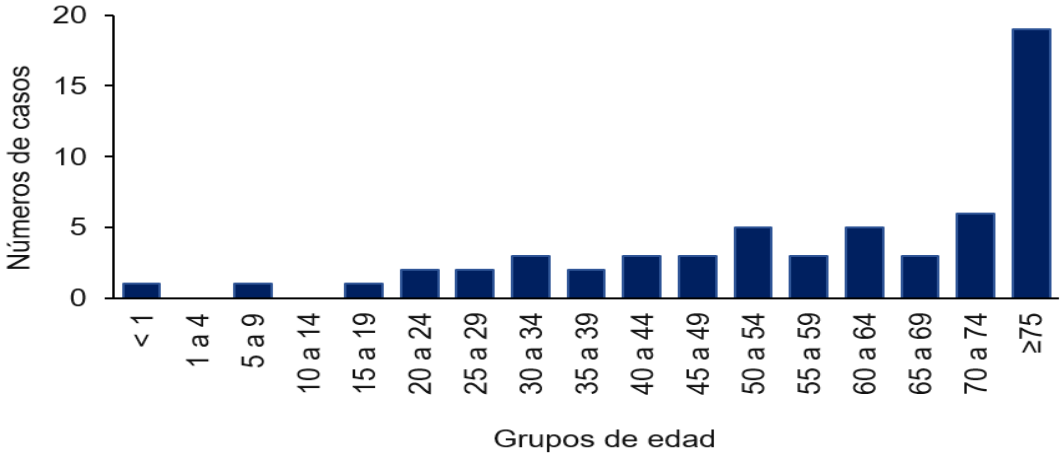
- Casos acumulados de miasis por gusano barrenado en humanos suman un total de 59 casos
- Casos por grupos de edad tienen un predominio en las personas de 20 a 64 años (28/59) y las adultas de 65 y más años con más casos reportados (28/59)
-

Gráfico 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador según SE de la 01 a la 42, 2026



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador según grupos de edad quinquenal, de la SE 01 a la 42, 2026



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026

En 2026, hasta la SE 42, la distribución de los casos de miasis por gusano barrenador en humanos evidenció un predominio del sexo masculino, que concentró el 69,49% (41/59) de los casos notificados, con una tasa de incidencia de 1,6 casos por 100 000 habitantes. Por su parte, el sexo femenino representó el 30,51% (18/59) de los casos, con una tasa de incidencia de 0,7 casos por 100 000 habitantes.

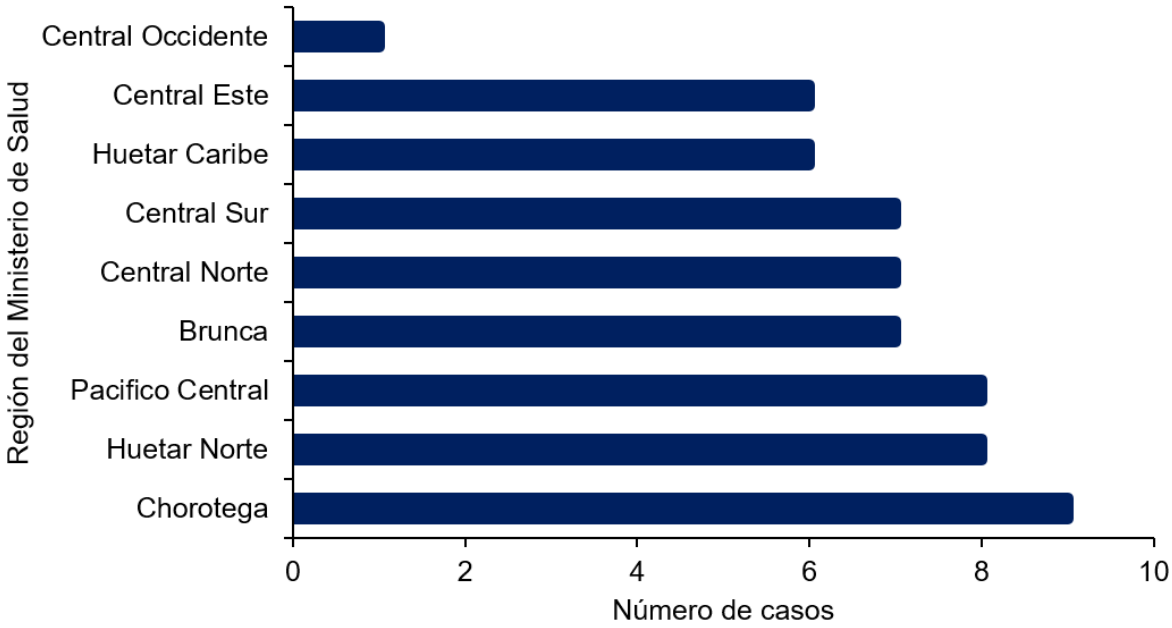
Tabla 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos y tasas (tasa p/100.000 habitantes) según provincia de procedencia, de la SE 01 a 42, 2026

Provincias	Casos	Tasas
Total	**59**	**1,1**
San José	10	0,6
Alajuela	12	1,1
Cartago	4	0,7
Heredia	5	0,9
Guanacaste	9	2,2
Puntarenas	13	2,6
Limón	6	1,3

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026

En la Tabla 1 se muestra la distribución de los casos de miasis por gusano barrenador en humanos notificados hasta la SE 42, según provincia de procedencia. Las provincias de Puntarenas (13/59) y Alajuela (12/59) concentran el mayor número de casos.

Gráfico 3
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos según región del Ministerio de Salud de procedencia, de la SE 01 a 42, 2026



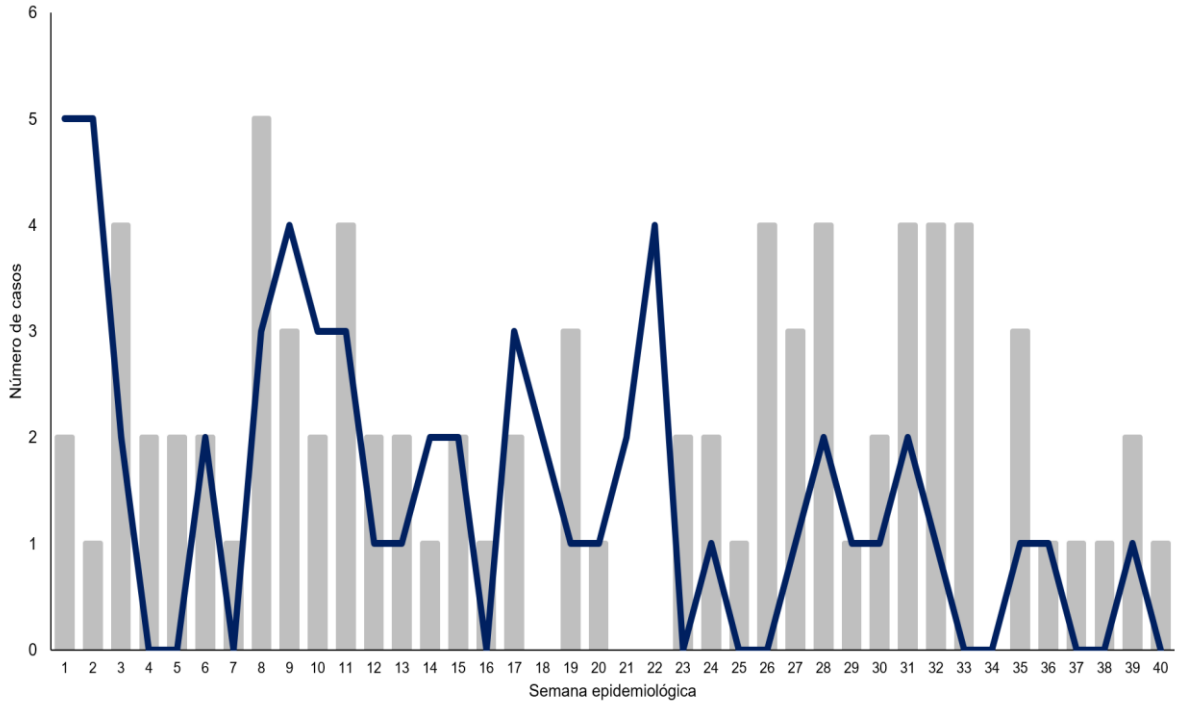
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026

En el Gráfico 3 se presenta la distribución de los casos de miasis por gusano barrenador en humanos notificados hasta la SE 42 en las nueve regiones rectoras del Ministerio de Salud. La Región Chorotega concentró el mayor número de casos, con 9 de los 59 casos registrados durante el período analizado.

Por su parte, el Gráfico 4 muestra el comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos entre las SE 1 a la 42 de los años 2025 y 2026. Durante el año 2026 se notificaron 58 casos confirmados, mientras que para el mismo período

de 2025 se habían confirmado 83 casos. Lo anterior representa una disminución de 24 casos (28,92%) en comparación con el año anterior.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador, según SE, de la SE 01 a la 42 del 2025 y del 2026



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025 y 2026

En atención a la declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria Epidémica para el control y erradicación del Gusano Barrenador (*Cochliomyia hominivorax*), establecida mediante el Decreto Ejecutivo N° 44382–MAG, y considerando que la mosca continúa circulando en el territorio nacional, resulta de suma importancia que, ante la detección de un caso sospechoso en humanos, se active de manera inmediata la coordinación interinstitucional e intersectorial bajo el enfoque de **Una Sola Salud**.

Dicha coordinación involucra la participación del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), según corresponda. El propósito es identificar oportunamente casos sospechosos en humanos y/o animales y garantizar su atención conforme a lo establecido en el **Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos**.

A continuación, se presentan las disposiciones generales para la prevención y control de la enfermedad:

- Acudir oportunamente a los servicios de salud públicos o privados ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad, tales como dolor, malestar y picazón en el sitio de la lesión, enrojecimiento de la piel, herida con secreción, sensación que se mueve y con frecuencia, se pueden observar huevecillos y/o larvas visibles en la lesión.
- Mantener una adecuada higiene personal, incluyendo el lavado frecuente de manos con agua y jabón.
- Realizar el control, tratamiento y cuidado higiénico de las lesiones conforme a las indicaciones del médico tratante.
- Mantener vigilancia y control en el cuidado de los animales, efectuando revisiones periódicas y la curación de todas las heridas. Asimismo, se deberá notificar a las autoridades de salud animal (MAG-SENASA y/o MINAE) la aparición de animales con gusaneras, a fin de garantizar su atención oportuna.

Comportamiento de trastornos mentales notificados en personas adultas mayores

Introducción

El envejecimiento demográfico global avanza a un ritmo acelerado, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la población de 60 años o más pasará de 1100 millones en 2023 a 2100 millones en 2050, alcanzando los 2500 millones a finales de la década de 2060, momento en el que superará al número de menores de 18 años. Este incremento es aún más drástico en el grupo de 80 años o más, el cual se triplicará hasta llegar a los 545 millones en 2060.
Esta transición demográfica plantea serios desafíos de salud pública, especialmente en el ámbito de la salud mental, ya que se calcula que el 14,75% de las personas de 70 años o más padece algún trastorno mental, siendo la ansiedad y la depresión los más comunes. Entre los principales factores de riesgo que agravan esta situación se encuentran el aislamiento social y la soledad, problemas que afectan a casi una cuarta parte de la población mayor, a este panorama se suma el impacto del maltrato: una de cada seis personas mayores sufre violencia física, verbal, psicológica, sexual, económica o desatención frecuentemente por parte de sus propios cuidadores, un factor crítico que deteriora gravemente su bienestar y desencadena cuadros severos de ansiedad y depresión (Organización Mundial de la Salud, 2026).

Los problemas de salud mental de las personas mayores suelen pasar inadvertidos o no tratarse adecuadamente, además, la estigmatización asociada puede hacer que no puedan o quieran pedir ayuda, en la vejez, la salud mental depende tanto del entorno físico y social como de los efectos acumulados de las experiencias vividas y de las dificultades propias del envejecimiento, como el duelo, la disminución de los ingresos, la pérdida de metas o de una ocupación que dé sentido a la vida tras la jubilación y el deterioro de las capacidades físicas y mentales y de la capacidad para desenvolverse, pese a sus numerosas contribuciones a la sociedad, muchas personas mayores son discriminadas debido a su edad, lo que puede perjudicar gravemente su salud mental.

El aislamiento social y la soledad afectan a cerca de una cuarta parte de las personas mayores y constituyen importantes factores de riesgo para la salud mental en la vejez no está de más indicar que una de cada seis mayores sufre malos tratos físicos, verbales, psicológicos, sexuales o económicos, o desatención, a menudo a manos de quienes la cuidan, este maltrato tiene graves consecuencias y puede provocar depresión y ansiedad.

Las medidas de promoción y prevención de la salud mental dirigidas a las personas mayores tienen por objeto favorecer que envejezcan de forma saludable para ello es preciso crear entornos físicos y sociales que contribuyan al bienestar y permitan seguir realizando las actividades que consideran importantes, pese a la pérdida progresiva de facultades.

También es fundamental proteger a las personas mayores frente al edadismo y el maltrato las principales intervenciones en este ámbito son la adopción de políticas y leyes contra la discriminación, las actividades educativas y las iniciativas intergeneracionales, asimismo, existen diversas medidas de apoyo a los cuidadores, como los servicios de relevo, el asesoramiento, la formación, la ayuda económica y las intervenciones psicológicas.

Situación general del envejecimiento a nivel nacional

Según datos del INEC Costa Rica experimenta un envejecimiento demográfico rápido y acelerado, impulsado por el aumento de la esperanza de vida y una de las tasas de natalidad más bajas de la región (1,3 hijos por mujer). (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2026).

El país se encuentra en proceso de envejecimiento poblacional, la población de 65 años y más representa más del diez por ciento de la población total y se proyecta que esta situación se acentúe, aún más en 2050 cuando represente un poco más de una cuarta parte de la población total. Esta celeridad del proceso obedece a que el país se encuentra en el proceso de transición demográfica avanzada, pero que, además, su proceso de disminución de la fecundidad fue particularmente más acelerado que el resto de países que se encuentran en esta misma etapa, dado que el país pasó de una fecundidad considerablemente alta en la década de los sesenta (seis hijos e hijas por mujer), a un valor por debajo del nivel reemplazo en 2004 (2,07 hijos e hijas por mujer), y un nivel de ultra baja fecundidad en 2020 (1,42 hijas

e hijos por mujer) proceso que en algunos países tardó varios siglos, en nuestro país se alcanzó en sesenta años.
El país muestra una sostenida desaceleración en el crecimiento, incluso llegará el momento en que la población empezará a disminuir, lo cual se proyecta suceda alrededor de 2045, la población para 2025 será de 5 191 823, llegará a un valor máximo en 2044 de 5 439 639 y a partir de ahí, inicia el decrecimiento paulatino.
En este proceso el envejecimiento acelerado de la población en Costa Rica que duplicará su proporción de personas de 65 años o más a partir del 2024 en forma progresiva hacia el 2044 se vincula científicamente con un aumento en la incidencia y prevalencia de diversos trastornos mentales y neuropsiquiátricos y de salud mental por los siguientes factores tanto biológicos, como funcionales y de salud, así como factores psicosociales y relacionados con conducta suicida entre otros.

Situación epidemiológica de los trastornos mentales (alzheimer, demencia vascular, depresión, intento de suicidio) en personas adultas mayores.

Es así como a la semana epidemiológica 38 de 2026 se notificaron alrededor de 1656 casos de trastornos mentales en población adulta mayor, predominando la depresión, seguida por la demencia vascular, en este caso la distribución por sexo muestra una mayor afectación en mujeres con 1105 casos, lo que representa un 66,7%, mientras que los hombres registraron 551 casos, dato que implica un 33,3%, para una razón mujer: hombre de 2.0:1, lo que indica es que los trastornos mentales están afectando el doble a las mujeres que a los hombres.
Está claro que la depresión constituye casi tres cuartas partes de todos los casos notificados, que la demencia vascular representa una quinta parte del total, que los casos de Alzheimer son relativamente pocos, posiblemente asociados a diagnósticos más específicos y que el intento de suicidio, aunque aporta el porcentaje más bajo, se considera para este grupo etario un problema de salud mental que empieza a tener relevancia.

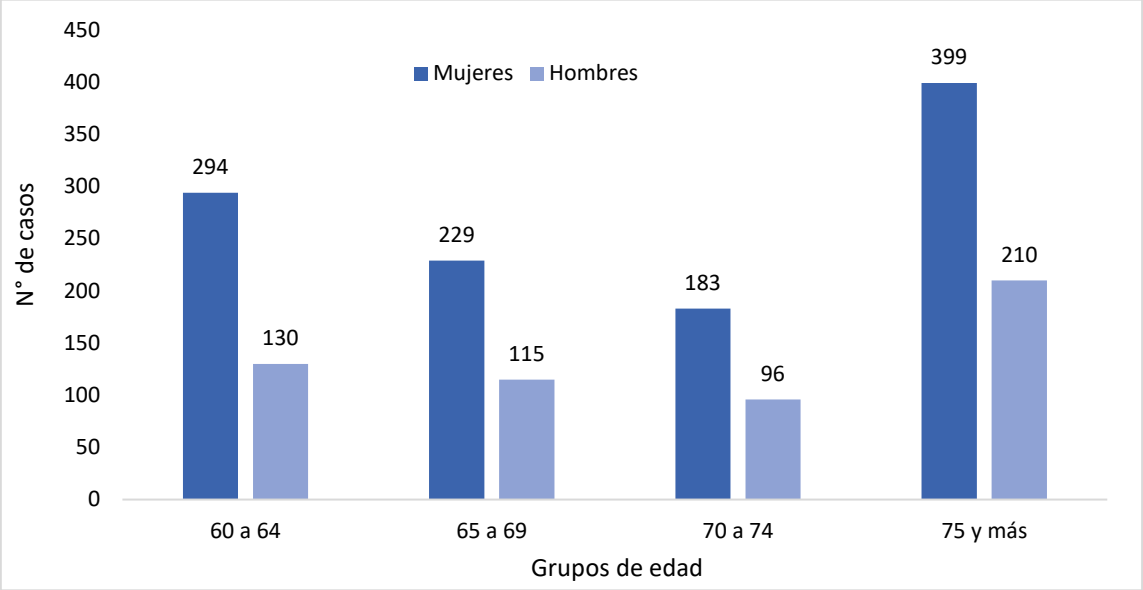
Tabla 1.
Costa Rica, distribución de casos en población adulta mayor por tipo de trastorno mental, SE 38-2026. (*)

Trastorno mental	Casos	%
Depresión	1218	73,6
Demencia vascular	337	20,4
Intento de suicidio	78	4,7
Alzheimer	23	1,4
Total	***1656***	***100%***

(*) Datos preliminares SE38-2026
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud

Como se evidencia en el gráfico siguiente el grupo de 75 y más concentra más de un tercio de las notificaciones, constituyéndose en el principal grupo etario aportador de casos y grupo de 70 a 74 años presentó la menor frecuencia.
Por otro lado el comportamiento muestra una reducción en los otros grupos etarios sobre todo en los grupos de 60 a 64, esto sugiere un cambio en el perfil de morbilidad mental asociado al envejecimiento avanzado y en donde los trastornos neurocognitivos adquieren mayor peso, particularmente las demencias, tal y como se evidencia más adelante.
Pero además es claro que en todos los grupos de edad hay un predominio femenino, pero es en el grupo de edad de 75 y más en donde tanto mujeres como hombres concentran la mayor proporción de casos.

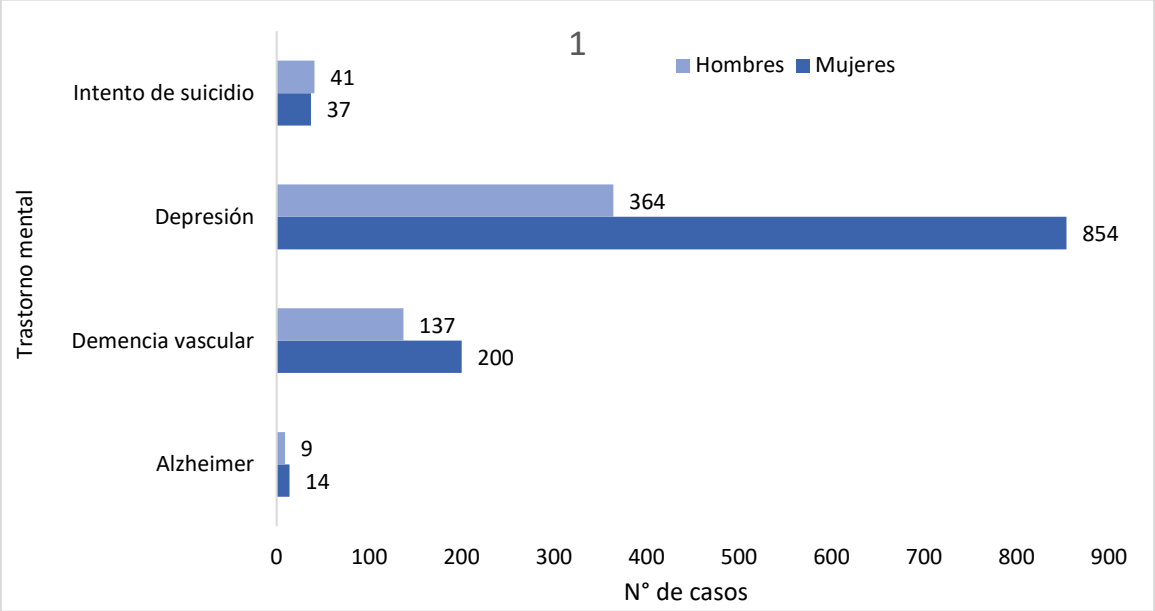
Gráfico 1.
Costa Rica: casos notificados de trastornos mentales en población adulta mayor según grupos de edad y sexo, SE38-2026 (*)



(*) Datos preliminares SE38-2026
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud

El siguiente gráfico muestra que en la mayoría de los trastornos mentales hay un claro predominio femenino, sobre todo en la depresión que representa aproximadamente el 70%, eso sí el único evento con predominio en hombres corresponde al intento de suicidio en donde aportan un 52,6%, cabe decir que este patrón coincide con la evidencia epidemiológica que señala una mayor frecuencia de depresión diagnosticada en mujeres y mayor letalidad y conducta suicida en hombres adultos mayores.

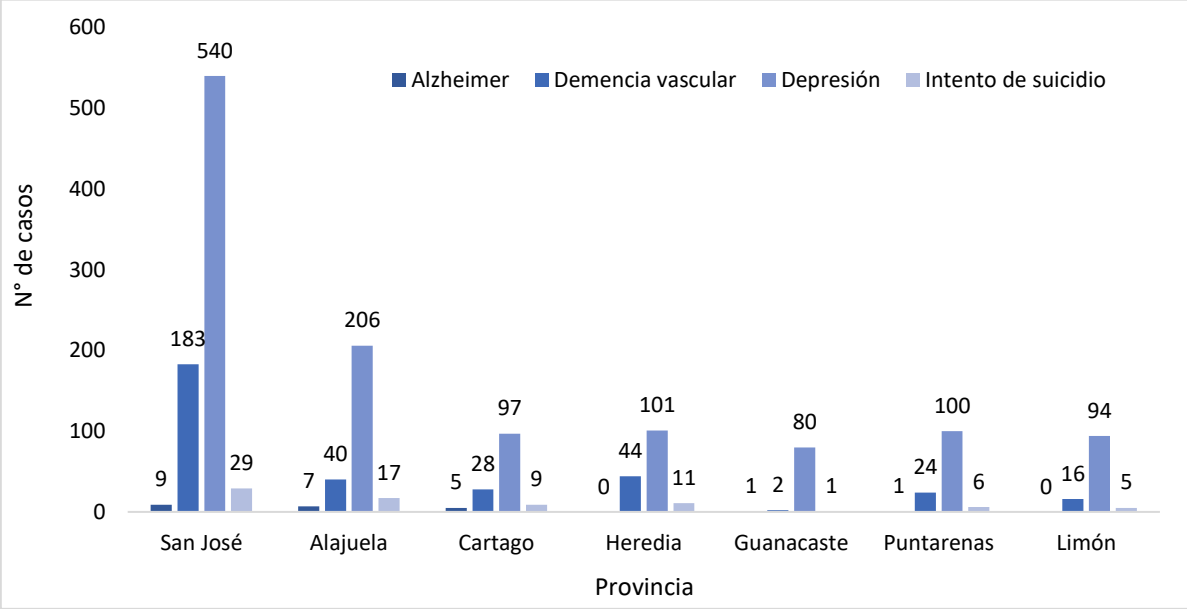
Gráfico 2.
Costa Rica: casos notificados de trastornos mentales en población adulta mayor por tipo de trastorno, según sexo, SE38-2026 (*)



(*) Datos preliminares SE38-2026
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud

En cuanto a la distribución geográfica se evidencia una marcada concentración de casos en San José, que aporta casi la mitad de las notificaciones nacionales y más de la mitad de casos de demencia vascular. Ahora bien independientemente de la provincia analizada, la depresión constituye el principal trastorno reportado, representando el 64,7% y el 95,2% de los casos en provincias.
Asimismo, la demencia vascular si sitúa como el segundo evento en importancia epidemiológica, especialmente en San José y Heredia, mientras que el Alzheimer y los intentos de suicidio mantienen frecuencias menores dentro del patrón observado en dicha SE38-2026.

Gráfico 3
Costa Rica: casos notificados de trastornos mentales en población adulta mayor por tipo de trastorno, según provincia, SE38-2026 (*)



(*) Datos preliminares SE38-2026
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud

En siguiente gráfico evidencia patrones diferenciales según tipo de trastorno, en este caso la depresión es principal evento en todos los grupos de edad y concentra mayor número de casos en personas entre los 60 a 64 años de edad.

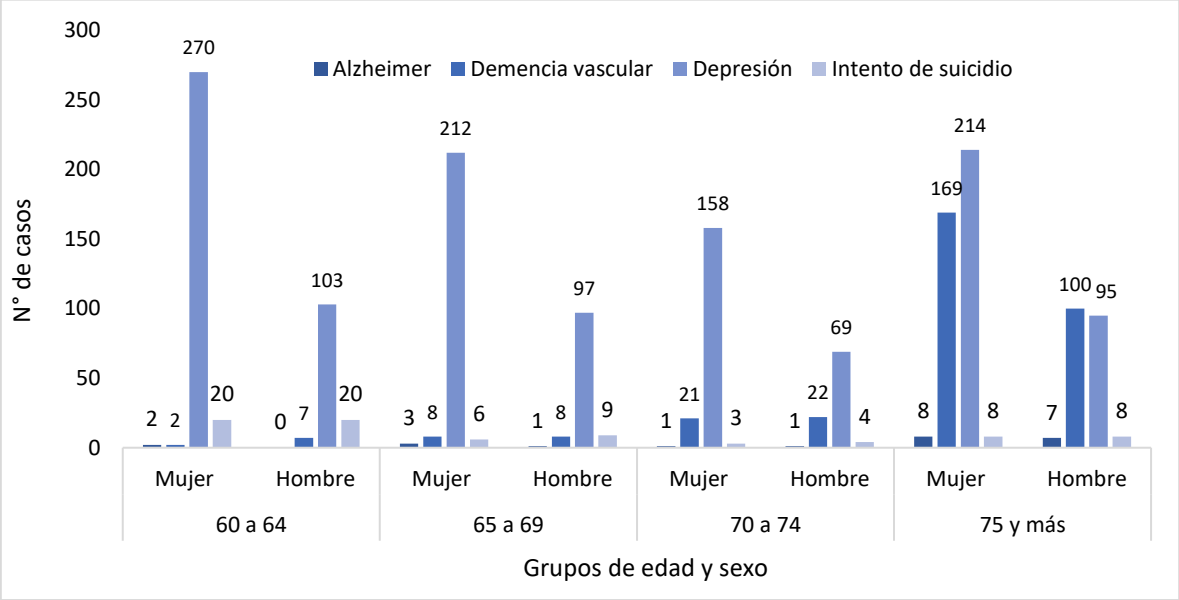
En contraste los trastornos neurocognitivos muestran una clara asociación con edades avanzadas, la demencia vascular aumenta progresivamente conforme se incrementa la edad y alcanza su máxima frecuencia en personas de 75 años y más, grupo que concentra cerca del 80% de los casos.

De manera similar la mayoría de casos de Alzheimer se presenta en edades avanzadas y por otra parte los intentos de suicidio se concentran en adultos mayores entre los 60 a 64 años, disminuyendo en los grupos etarios posteriores.

Es decir el aumento o incremento en las notificaciones en población adulta mayor sobre todo de 75 años y más se explica por la participación creciente de los trastornos neurocognitivos y no necesariamente por un aumento generalizado de todos los trastornos mentales.

Gráfico 4

Costa Rica: casos notificados de trastornos mentales en población adulta mayor por tipo de trastorno, según grupo de edad y sexo, SE38-2026 (*)



(*) Datos preliminares SE38-2026

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de

Referencias

(1) Organización Mundial de la Salud. (20 de julio de 2026). Salud mental de las personas mayores. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults.

(2) Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2026). *Proceso de envejecimiento en Costa Rica: Evolución de la población de 65 años y más*. INEC.